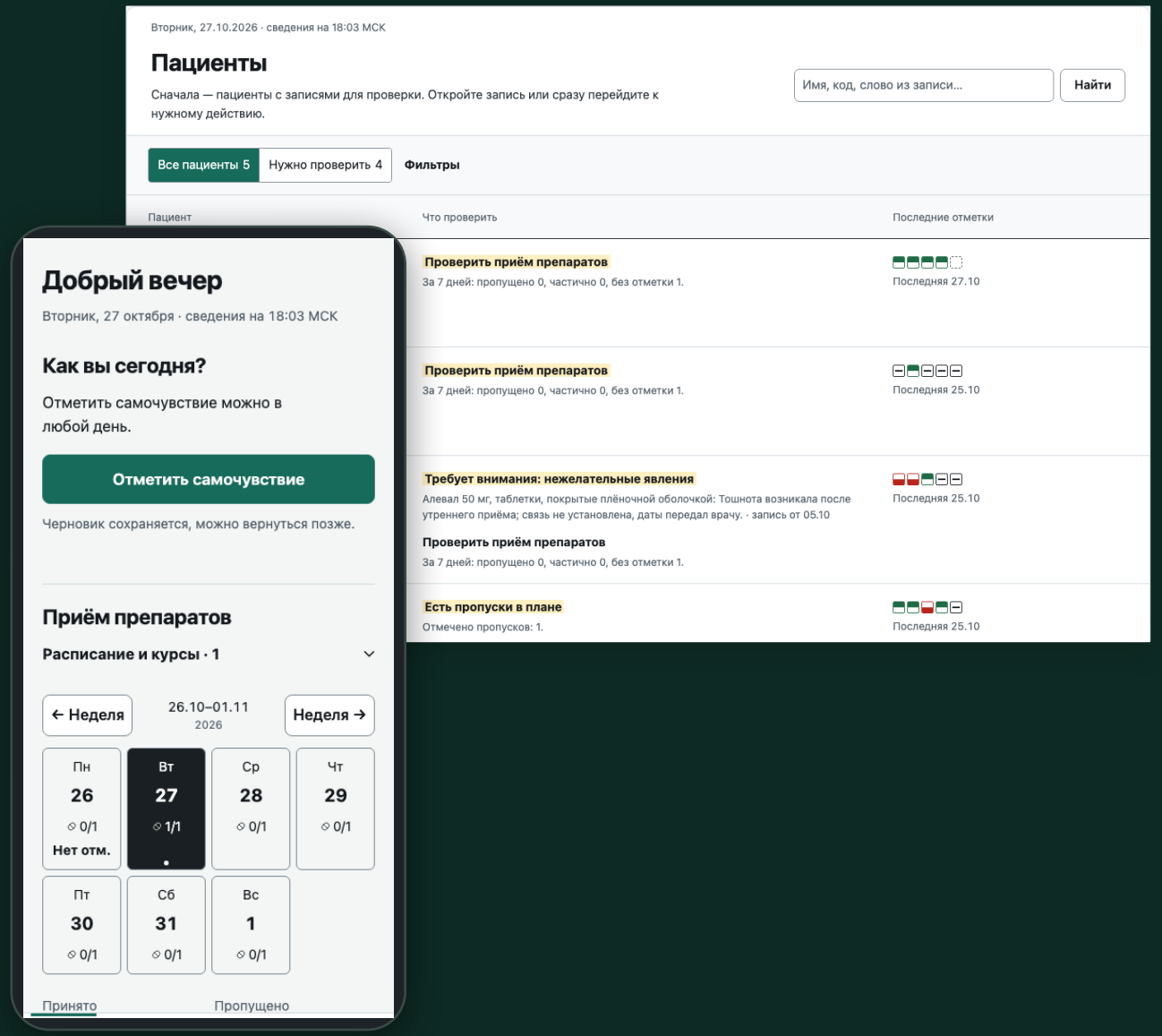
КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ «КЛИНИЧЕСКИЙ КОМПАС» · 2026

Шаг вперёд

Психиатр и пациент между приёмами видят одну историю болезни. Решение всегда за врачом.



Капитан — Идиятуллин Ильназ Алмазович
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России
Педиатрический факультет · Казань, 2026

1 · ИДЕЯ

Между приёмами проходят недели, и врач узнаёт о них по памяти пациента

280 млн

человек в мире живут с депрессией (ВОЗ, 2023). Лечение длится месяцами, а врач видит пациента раз в несколько недель.

Что сейчас теряется

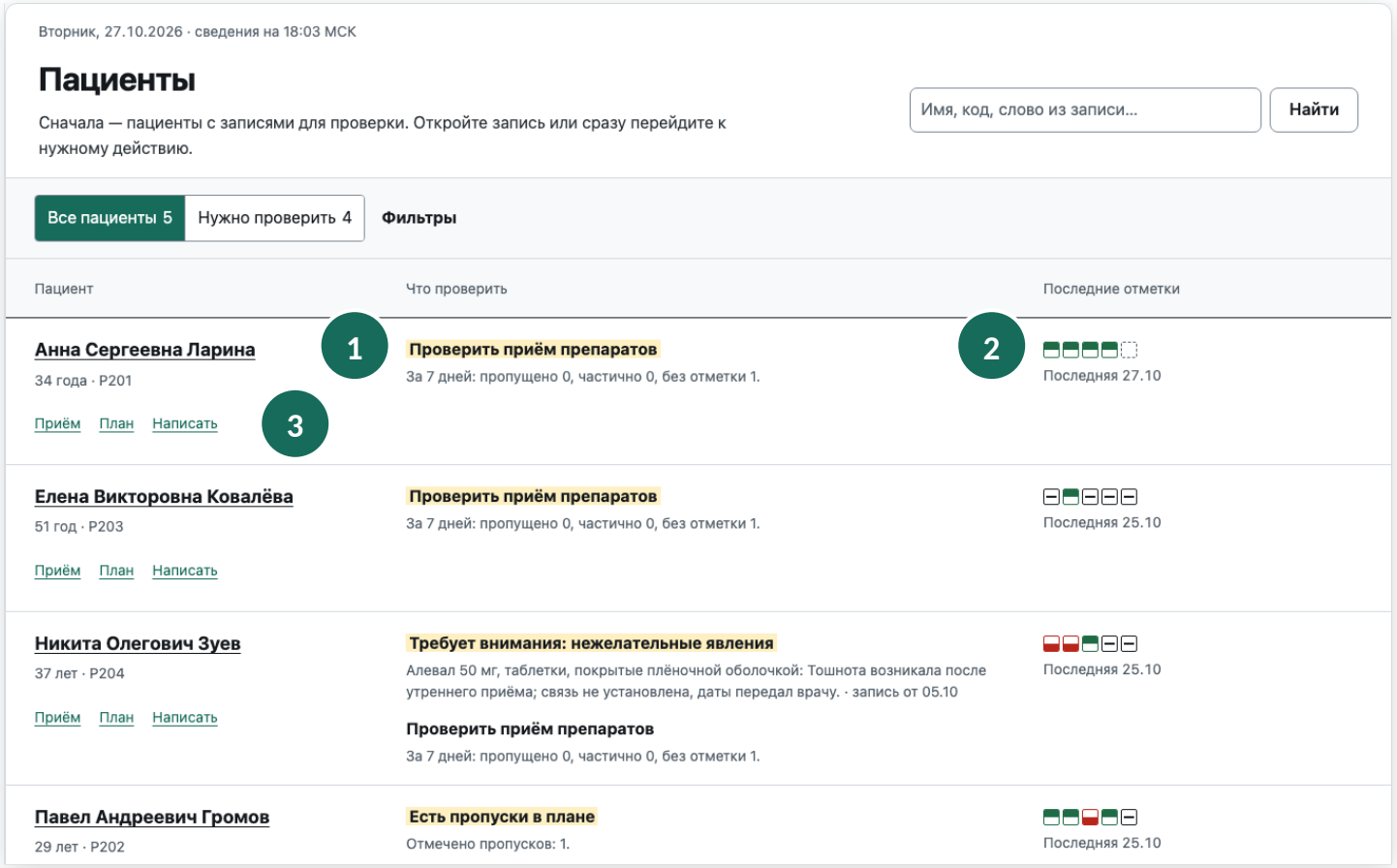
- сон, побочные эффекты и пропуски таблеток вспоминают задним числом
- анкеты остаются на бумаге, динамики не видно
- переписка в мессенджере не связана с планом лечения

Наше решение

1. **Врач на приёме** утверждает план и расписание препаратов
2. **Пациент дома** отмечает самочувствие и каждый приём таблеток, заполняет PHQ-9, GAD-7, DASS-42
3. **Перед приёмом** врач видит, что изменилось, и откуда взят каждый факт
4. **Решение** принимает врач. Сервис ничего не назначает сам

2 · ПРОТОТИП

Врач за минуту видит, кому из пациентов нужно внимание и почему



Все пациенты и истории на снимках вымышленные.

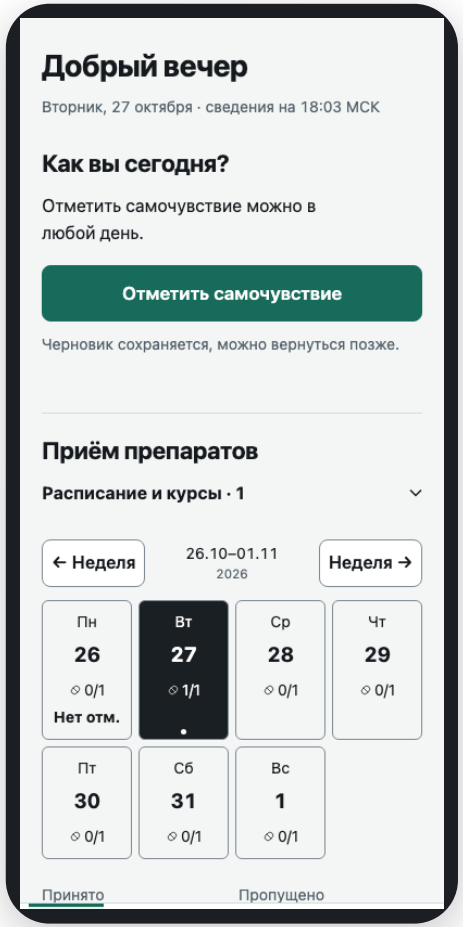
1. Конкретная причина проверки и ссылка на запись, из которой она взялась

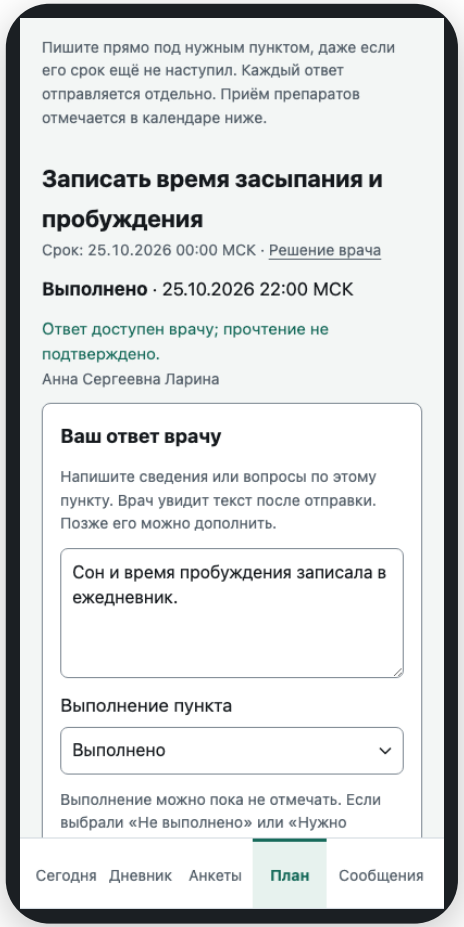
2. Приём препаратов за неделю. Пропуск и «нет отметки» показаны по-разному

3. Из строки сразу в приём, план или сообщение пациенту

Список отсортирован: сначала те, у кого есть что проверить. Цвет всегда продублирован словом.

Пациенту хватает нескольких касаний, и он видит, что запись дошла





- **Одна главная кнопка**
  на телефоне видна без прокрутки
- **Календарь препаратов**
  отметка каждого приёма, даже половины таблетки
- **Ответ под пунктом плана**
  врач видит его рядом с этим пунктом
- **Анкеты PHQ-9, GAD-7, DASS-42**
  в точных русских версиях; баллы видит только врач
- **Черновик хранится на сервере**
  повторное нажатие ничего не задвоит

Оба кабинета полноценно работают на телефоне и компьютере, без установки приложения

ЧЕМ МЫ ЛУЧШЕ

Чем мы отличаемся от бумажного дневника и переписки в мессенджере

	Как сейчас	Шаг вперёд
Сведения между приёмами	со слов пациента, задним числом	**каждый день, с автором и временем записи**
Откуда взялся факт	не восстановить	**ссылка на исходную запись пациента или врача**
Пропуски и пробелы	выглядят как «всё хорошо»	**пропуск, «нет отметки» и неизвестное видны отдельно**
Анкеты	бумага, сумма в уме	**исходные ответы, суммы по шкалам, графики динамики**
Данные пациента	в личной переписке	**только у лечащего врача, без внешних ИИ-сервисов и CDN**

Врач по-прежнему принимает все клинические решения: назначение, изменение терапии и плана проходят только после его подтверждения на сервере.

Прототип проверен автотестами на каждом этапе разработки

976
автотестов в наборе

100 %
проходят, ни одного пропущенного

8
внешних библиотек на весь сервис

102
этапа разработки приняты после проверки

Что проверяют отдельно

- ✓ Доступ по ролям: врач не открывает чужих пациентов, пациент — чужие записи
- ✓ Перезапуск сервера без потери данных
- ✓ Защита форм от подделки запросов (CSRF) и безопасный повтор отправки
- ✓ Вёрстка обоих кабинетов в Chromium и WebKit, экраны от 390 до 1440 px

Замер 27.10.2026: python -m unittest, 976 тестов за 7 мин 26 с, все проходят, пропусков нет. macOS, Python 3.13, только вымышленные данные.

4 · ДАЛЬШЕ

Следующий шаг: сервис сам замечает тревожные признаки и зовёт врача

1 **Данные**
анкеты, дневник, анамнез, записи приёма

→

2 **Проверка**
проверяемые правила и языковая модель

→

3 **Сигнал врачу**
опасные сочетания и ухудшение — только лечащему врачу

→

4 **Предложение**
гипотеза диагноза с альтернативами, проект плана и лечения

→

5 **Решение врача**
без его подтверждения ничего не применяется

Серверная часть: 16 из 19 этапов приняты



Готово
правила риска, гипотезы с основаниями и противоречиями, проверка лекарственных ограничений, доставка сигнала врачу

Осталось
замер скорости и устойчивости, сквозная приёмка, проверка врачами-экспертами, вывод в кабинет врача

4 · ВНЕДРЕНИЕ

За год доводим модуль, переходим на Go и выходим в пилот

1

IV кв. 2026

Модуль тревожных признаков

скорость, сквозная приёмка, вывод в кабинет врача

2

I кв. 2027

Перенос сервера на Go

быстрее ответ, один исполняемый файл, проще установка в клинике

3

II кв. 2027

Пилот у психиатров

время подготовки к приёму, доля заполненных анкет, оценка удобства врачами

4

III–IV кв. 2027

Регистрация медизделия

клинические испытания; ПО с ИИ — класс риска 3 по ПП РФ № 1684

Данные пациента
152-ФЗ и 323-ФЗ: согласие, хранение в России, врачебная тайна

Что нам нужно
клиническая база для пилота и психиатры-эксперты для приёмки модуля

5 · КОМАНДА

Четыре медика и разработчик



капитан

Идиятуллин
Ильназ Алмазович
медицина



Сибагатуллин
Азамат Ильдарович
разработка



Галицкий
Марк Игоревич
медицина



Мурадисинов
Мурадисин Идрисович
медицина



Гайнатуллин
Ильназ Рамилевич
медицина

Спасибо организаторам чемпионата — НМИЦ ПН имени В. П. Сербского и Сеченовскому Университету, партнёру «Авинейро», нашим трекерам и экспертам, а также Казанскому ГМУ.

Шаг вперёд

Врач видит, что изменилось между приёмами.
Решение остаётся за ним.



Код на GitHub



Демонстрация

Спасибо! Готовы ответить на вопросы

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение: как измеряли и откуда цифры

- Автотесты: python -m unittest discover -s apps/tests, 27.10.2026, macOS, Python 3.13. Всего 976, прошли 976, пропущенных нет.
- Перед замером устаревшие тесты обновлены под текущий интерфейс: проверки удалённого экрана документов заменены проверками того, что прежние записи сохраняются, а экран больше недоступен.
- Покрытие кода (замер до обновления тестов): coverage.py 7.6.10 с учётом ветвлений, пакет apps/compass, 87 %.
- Этапы разработки: 102 тега slice/* в Git; каждый этап закрывается проверкой и записью в memory/.
- Модуль тревожных признаков: этапы BE01–BE16 приняты технически, BE17–BE19 (скорость, сквозная приёмка, клиническая проверка) впереди. В интерфейс модуль не выведен.
- Вёрстка: снимки Chromium и WebKit на ширине 390 и 1440 px (evidence/UI10). Все пациенты и истории в прототипе вымышленные.
- ВОЗ: Depressive disorder (depression), fact sheet, 2023 — около 280 млн человек в мире.
- Регистрация медизделий: ПП РФ от 30.11.2024 № 1684; программное обеспечение с технологиями ИИ относится к классу риска 3.